

的血管造影検査が必要になることもある。なお、緩徐な出血の場合には時間を経て血胸が明らかになる場合があるので注意が必要である。

血液検査としては、貧血の有無と輸血の要否判断のために末梢血検査や血液型検査、背景因子探索や造影剤使用の可否のために電解質、凝固機能検査や肝機能検査、腎機能検査などを行う。

治療

選択肢としては胸腔ドレナージ、血管塞栓術、胸腔鏡手術、開胸手術である。

外傷性血胸で、胸部レントゲンで胸水貯留がわかるような血胸 (>300 mL) の場合、まずは胸腔ドレナージを検討する。血胸では凝血によって閉塞しやすく、できるだけ太めのドレナージチューブ (24 Fr 以上) を用いることが多い²⁾。輸血にも使える輸液ルートを確認し、血圧や SpO₂ のモニター下で、緊急対応が可能な準備をしておく。X 線検査ないし胸部 CT によって適当なドレナージ部位を選択し、胸部超音波検査で部位を決定する。

胸部 CT で特定の血管からの出血が疑われる場合には選択的血管造影を行い、塞栓術を検討する (図 2)。

胸腔ドレナージ直後に 1,500 mL を超える出血がある場合、時間あたり 150~200 mL の出血が 2~4 時間持続する場合、血行動態を維持するのに輸血を継続しなければならぬ場合には、緊急手術を行う^{1, 3)}。持続性の出血があっても血行動態が安定しているならば胸腔鏡手術が有用である。出血量や気胸による気漏が多量である場合には、開胸手術が選択される。

ドレナージで肺が十分に再膨張すれば、胸膜面からの出血や気漏は壁側胸膜と肺胸膜が密着して圧迫止血・閉鎖される期待が持てる。気漏がなく、排液量も減少すればチューブを抜去する。持続性出血がなくなっても X 線検査にて血腫が遺残すると、膿胸の合

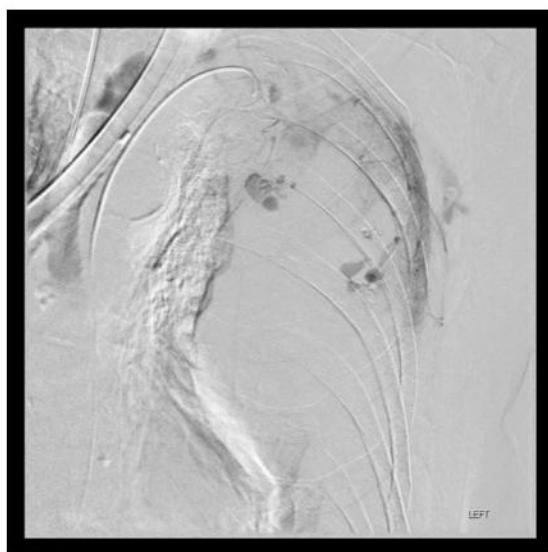


図 2 気管支動脈瘤破裂に対する塞栓術後

a: 造影により気管支動脈瘤を特定し bronchial artery embolization: BAE を施行。

併や、数週間~数ヵ月後のびまん性胸膜肥厚 (線維胸郭) の原因になる。血腫の遺残に対してはドレナージチューブを追加するのではなく、3 日以内に VATS によって血腫を除去することが勧められる¹⁾。7 日以降になると癒着して VATS は困難になる。

胸腔ドレナージ管理中には膿胸の予防のため少なくとも 24 時間は抗菌薬を投与する³⁾。止血異常を背景とする血胸の場合には、止血薬投与、血小板製剤や新鮮凍結血漿輸注などを行う。

文献

- 1) Light RW: Hemothorax. Pleural diseases, 5th Ed, Lippincott Williams & Wilkins, p340, 2007
- 2) Light RW: Respirology **16**: 245, 2011
- 3) Boersma WG, et al: Respir Med **104**: 1583, 2010